

I Disturbi di Personalità — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 08

Hai già letto il dettagliato? Bene. Questa è la versione da tenere aperta la sera prima dell'esame — tutto l'essenziale, senza fronzoli. Ci sei dentro in dieci minuti.

Temperamento, carattere, personalità

- **Temperamento** → base biologica, congenita; risposta emotiva agli stimoli; relativamente stabile (ma influenzabile da fattori prenatali/perinatali)
- **Carattere** → tratti acquisiti dall'interazione con l'ambiente; "marchio" della storia di vita
- **Personalità** → risultato dell'interazione tra i due; modalità stabili di *pensare, sentire, comportarsi e mettersi in relazione* (Lingiardi & McWilliams, 2018)

9 variabili temperamentali (Thomas, Chess & Birch, 1968): livello di attività, regolarità biologica, approccio/ritiro, adattabilità, sensibilità agli stimoli, intensità delle reazioni, qualità dell'umore, distraibilità, persistenza.

Tre tipologie di bambini: **facili** (regolari, positivi), **difficili** (~10%, opposto), **lenta attivazione** (risposte attenuate).

Goodness of fit: grado di armonia tra temperamento del bambino e ambiente. *La relazione di attaccamento dipende da entrambi.*

Tratto (stabile nel tempo) vs **stato** (temporaneo, reattivo) → distinzione clinica: *i disturbi di personalità derivano da tratti; le sindromi cliniche da stati.*

Modelli di tratti

- **Eysenck**: estroversione, nevroticismo, psicoticismo (quest'ultimo controverso e abbandonato)
 - **Big Five** (Costa & McCrae, 1988): estroversione + nevroticismo + **gradevolezza** + **coscienziosità** + **apertura all'esperienza** — ogni fattore è un continuum bidimensionale
 - **Corazza caratteriale** (Reich): meccanismi difensivi abituali formati nell'infanzia — funzionali allora, **potenzialmente rigidi nell'adulto**
-

Da stile a disturbo

- **Stile di personalità** → tratti presenti ma adattivi, non compromettono il funzionamento
- **Disturbo di personalità** → tratti estremi, rigidi, pervasivi → causano sofferenza e/o compromissione significativa

Modello bio-psico-sociale (Paris, 1997): - Fattori biologici (temperamento ereditario, disfunzioni neuropsicologiche) - Fattori psicologici (traumi, stili di accudimento abnormi) - Fattori sociali (disgregazione valori, perdita riti iniziatici) - **Diateasi** (vulnerabilità) + **stress** → disturbo

Definizione DSM-5-TR

Pattern abituale di esperienza interiore e comportamento che: - Devia marcatamente rispetto alle aspettative culturali - È **pervasivo e inflessibile** in molteplici situazioni - Causa disagio significativo o compromissione funzionale - È **stabile e di lunga durata**, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta

Si manifesta in almeno **2** di: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale, controllo degli impulsi.

Concetti da ricordare: - **Egosintonia**: la persona non percepisce i propri tratti come problematici → **difficile portarla in terapia** - **Culturale**: valutare sempre il

contesto culturale - **Internalizzante** (soffrono dentro, si incolpano) vs **esternalizzante** (fanno soffrire gli altri, incolpano gli altri) → il BPD oscilla tra i due

I tre cluster del DSM

Cluster A — Strani ed eccentrici

Disturbo	Nucleo	Meccanismo difensivo
Paranoide	Diffidenza e sospettosità pervasive; motivazioni altrui interpretate come malevole	Proiezione, identificazione proiettiva
Schizoide	Distacco dalle relazioni; gamma emotiva ristretta; non desidera relazioni strette	Ritiro
Schizotipico	Deficit sociali + distorsioni cognitive/ percettive + eccentricità; più vicino alla psicosi	Difese primitive

Credenze patogene paranoide: sé = "sono in pericolo costante"; altri = "pronti ad attaccarmi" Credenze patogene schizoide: sé = "amore e dipendenza sono pericolosi"; altri = "mi invadono"

Cluster B — Drammatici, emotivi, imprevedibili

Disturbo	Nucleo	Meccanismo difensivo
Antisociale	Violazione pervasiva dei diritti altrui; no rimorso; esordio prima 15 anni	Controllo onnipotente
Borderline		

Disturbo	Nucleo	Meccanismo difensivo
	Instabilità relazioni, immagine di sé e umore; marcata impulsività	Scissione, identificazione proiettiva, acting out
Istrionico	Emotività eccessiva e ricerca di attenzione; seduttività inappropriata	—
Narcisistico	Grandiosità, bisogno di ammirazione, mancanza di empatia emotiva	Idealizzazione e svalutazione

Borderline in dettaglio (~20% dei pazienti psichiatrici): - **Sforzi disperati per evitare l'abbandono** (reale o immaginario) - Relazioni intense e instabili: idealizzazione → svalutazione - Identità instabile; impulsività; **automutilazione (80% dei ricoverati)** - Instabilità affettiva rapida; rabbia intensa; sentimenti cronici di vuoto - Ideazione paranoide transitoria / sintomi dissociativi sotto stress - Credenza sé: "Non so chi sono"; credenza altri: "Tutti buoni o tutti cattivi"

Cluster C — Ansiosi e inibiti

Disturbo	Nucleo	Meccanismo difensivo
Evitante	Inibizione sociale; inadeguatezza; ipersensibilità al rifiuto — <i>vuole</i> le relazioni ma ha paura	Evitamento, simbolizzazione
Dipendente	Bisogno pervasivo di essere accuditi; sottomissione; paura della separazione	Regressione, somatizzazione
Ossessivo-compulsivo	Perfezionismo, controllo, rigidità — senza ossessioni/compulsioni del DOC	Isolamento affetti, intellettualizzazione

Distinzione DOCP vs DOC: nel DOCP non ci sono ossessioni né compulsioni vere — è un modo di vivere, egosintonico.

Distinzione evitante vs schizoide: l'evitante *vuole* relazioni ma ha paura del rifiuto; lo schizoide non le vuole affatto.

Il problema diagnostico

- DSM = approccio **categoriale** (sì/no) → **ma i disturbi sono dimensionali (continuum)**
 - Alta comorbidità: spesso una persona soddisfa criteri per più disturbi simultaneamente (studio Shea et al., 1999: veterani di guerra con PTSD soddisfacevano criteri per 82-90% paranoide, 52-92% borderline)
 - **PDM-2** (Lingiardi & McWilliams) → approccio più dimensionale e psicodinamico
-

Organizzazione di personalità (Kernberg)

"Borderline" in senso estensivo = livello strutturale, non solo diagnosi DSM.

Tre strutture di personalità su continuum di gravità:

	Identità	Difese	Esame di realtà
Nevrotica	Integrata	Mature	Conservato
Borderline	Diffusa (scissione)	Primitive	Conservato (vacilla sotto stress)
Psicotica	Gravemente compromessa	Primitive	Perduto

Organizzazione borderline sottende grosso modo i disturbi dei cluster A e B (i più gravi).

Trattamenti BPD

- **DBT** (Linehan): terapia dialettico-comportamentale, più validata
- **MBT**: basata sulla mentalizzazione
- **TFP** (Kernberg): basata sul transfert

Da ricordare: - **Temperamento** (biologico) + **carattere** (esperienziale) = **personalità** - **Tratto** (stabile) vs **stato** (temporaneo) → chiave per distinguere disturbi di personalità da sindromi cliniche - **I tre cluster** A (strani), B (drammatici), C (ansiosi) — con il BPD come caso più complesso e più frequente in clinica